



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
primář: MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA
ORFM Odd. rehabilit. a fyzikální med
ORFMHO Lůžka ORFM C
tel. +420973208281

U Vojenské nemocnice 1200 IČ: 61383082
169 02 Praha 6

PROPOUŠTĚCÍ ZPRÁVA

Pacient: **Mgr. SVOBODOVÁ EVA**
RČ: **426126/455**
ZP: **207**
Bytem: Sídliště 245/18G, Praha 6, 16500

Hospitalizován od: **07.09.2026** do: **15.09.2026**



Všech názorů nás zajímá

www.unm.cz/spokojenost

ZÁKLADNÍ ANAMNÉZA:

Prakt. lékař: MUDr. Lindovský, P-6

RA: bezvýznamná k současnému onemocnění

OA:

Hyperlipidémie

Ablace levého prsu, chemo a radioterapie r. 2025 pro karcinom, nyní na biologické a hormonální léčbě

V r. 2008 TEP levé kyčle (FNMotol)

Hysterektomie s adnexektomií pro myomy v 56 letech

Tonzilektomie v dětství

Operace nosních polypů

St. po operaci varixů bilat.

V r. 2015 - osteosyntéza periprotetické fr. levého femuru - MUDr. Chochola

Úrazy: 27.8.2026 - pád při vystupování z výtahu

EA: Aktuálně styk s virovým respiračním onemocněním 0

GA: porody 3, potraty 1 (UPT), menses do 56 let

Abusus: nekouří, alkohol příležitostně, dieta 3

SA: bydlí v bytě, s manželem

PA: v důchodu, žije sama v bytě P6, 0 schodů, dcera poblíž

FA: Flonidan 10 mg 1-0-0, Egilok 25 1-0-1, Vertenios 100 1-0-1 (nyní EX), Egistrozol 1mg 1-0-0, Sorvasta 20 mg 0-0-

1, Videmel 600/400IU 0-0-1, Loperon 2 mg dle p. (z dop. onkologa při průjmu, max. 8 tbl. /den), Nutridrink 1-0-1,

Protifar 2-2-2, Inhixa 0,4 0-0-1.

Alergie: pylly

NYNĚJŠÍ ONEMOCNĚNÍ:

Pacientka přijata překladem z ortopedie po revizi a reimplantaci femorální komponenty pro periprotetickou frakturu femuru při TEP kyčle vlevo. Operátér MUDr. Vaněček, výkon nekomplikovaný, v dalším pooperačním období řešena malnutrice (hypalbuminémie a snížení celkové bílkoviny při chr. onkologické léčbě), zaveden sipping a vysazení léčiva po konzultaci ošetřujícího onkologa. Dále podány 2x ERD pro anémii s normalizací hladiny hemoglobinu. 3.9. ozřejmení hypokalémie a zahájena substituce perorální s kontrolou mineralogramu. Krevní obraz ze dne: 5.9. erytrocyty $3.21 \times 10^{12}/l$, hemoglobin 97 g/l, CB 47.6 g/l, alb 25,8 g/l. Pro přetrvávající serózní sekreci z rány nasazena empirická ATB profylaxe. Před pádem pacientka chodila s 1 vycházkovou holí. Nyní zatím byla vertikalizována s pult.chodítkem, ušla 4 kroky s doprovodem terapeuta. Pacientku přijímáme překladem z ortopedie ÚVN k pooperační rehabilitaci.

STAV PŘI PŘIJETÍ:

Váha: 87.000 kg

Výška: 152.0 cm

TK: 117/79 mmHg

Tep: 87

Počet dech: 13

Teplota: 36.3

SUBJ.: bolest - levé kyčle minimální, analgetika dostačují, v noci dobře spí, dysurie, dráždění PMK neuguje, dýchá se dobře, bez palpitací. Dříve trpěla spíše průjemem, nyní několik dní nebyla na toaletě, břicho nebolí. Jiné obtíže neuguje. OBJ.: eupnoe, bez cyanózy, anikterus, obezita, při vědomí, hydratace v normě, orientována všemi kvalitami, psychomotorické tempo v normě, normoforická, hlava+krk bez patologického nálezu, náplň krčních žil nezvýšená, plíce: poklep plný+jasný, auskultačně dýchání alveolární, bez vedl. fenoménů, srdce: 2 ozvy, ohraničené, AS

pravidelná, periferie plně symetricky, břicho hůře prohmatné, bez patologie.
Dolní končetiny s klidnými varixy, perimaleolárními otoky, více vlevo. Mobilita: vyšetřena na lůžku, s dopomocí vertikalizace do sedu, stoje, pár kroků v PCH s výraznou dopomocí terapeuta.
Status localis: operovaný kloub krytý, krytí prosáklé serózní sekrecí, vstupně převaz. Svorky in situ.
Hybnost v oper. kloubu akt. 0, pooperačně algicky omezená.
Končetiny jsou akrálně dobře prokrvené, bez zn. TEN a bez paréz. PMK odvádí čistou moč.

VYŠETŘENÍ:

VÝSLEDKY BIOCHEMIE: Na : 140.3; K : 4.18; Cl : 103.2; CRP : 36.5;

15.09.2026 Farmakoterapeut. doporučení

- loratadin (LP Flonidan) aktuálně v dávce 5 mg/den (chronicky užíván v dávce 10 mg/den pro alergické projevy, v. s. pylovou alergii) --> po redukci dávky bez recidivy alergických obtíží - v plánu úplné vysazení léčiva (17.9.26);
- dále telefonicky kontaktována dispenzar. onkoložka (MUDr. Večeřová, FTN, 15.9.26 v 9h) ohledně znovunasazení LP Verzenios:

dle doporučení onkoložky ponechat Verzenios vysazen až do ukončení rehabilitační péče. Po dimisi do domácího prostředí má pacientka kontaktovat dispenzarizující onkoložku za účelem domluvy dalšího postupu, zejména termínu znovunasazení LP Verzenios a souvisejícího laboratorního monitoringu (zejména krevního obrazu).

TERAPIE BĚHEM HOSPITALIZACE:

KATEGORIE PACIENTA: 2

MONITORACE: TT: při podezření na zvýšenou. TK: út a št

REŽIM: režim na lůžku, posazování, polohování, antidekubitní program postranice, mísa, WC křeslo k lůžku, signalizace v dosahu, pohyb mimo lůžko v pultovém chodítku s doprovodem komp. osoby, chůze s dodržením prevence pádů, s odlehčením operované dolní končetiny; antiluxační prevence totální endoprotézy.
FYZIOTERAPIE: v pondělí až pátek 2x denně (v sobotu a ve státem uznaný svátek 1x denně):

- kineziologický rozbor
- návlek přesunů, vertikalizace do sedu, stoje, nácvik chůze s vhodnou komp. pomůckou
- ve vertikále zátěž operované DK do 30% celkové tělesné váhy
- léčebná tělesná výchova, manuální terapie
- korekce svalových dysbalancí, eutonizace měkkých tkání
- strečink oper. kloubu
- instruktáž pacienta k autoterapii a edukace k režimovým opatřením
- autoterapeutický deník
- mechanická prevence TEN, cévní gymnastika
- doporučení kompenzační pomůcky a instruktáž k jejímu použití
- omezení fyzioterapie: výrazná deondice, viz. režim

ERGOTERAPIE: pondělí až pátek 1x denně:
-vyšetření a korekce ergonomie ADL
-výběr vhodných kompenzačních pomůcek a instruktáž k jejich použití

OŠETŘOVÁNÍ:
- podsedák a klín k lůžku
- denně převaz rány po ortoped. operaci kyčle, krytí s betadine

PÉČE O VSTUPY: PMK 9. den
ODBĚRY: kontrola sonikace - tkáně neg. výsledek, kultivace z dřívku - též negativní

DG SOUHRN:

Zákl. dg: Z508 Rehabilitace, pooperační a poúrazová
Vedlejší dg: S7210, T840 Revize a reimplantace femorální komponenty pro periprotetickou fracturu femoru při TEP kyčle vlevo. 28.8.2026. Operatér MUDr. Vaněček
W0101 Pád na rovině po zakopnutí
D62 Postheemoragická anémie, podány 2x ERD
B876 Hypokalémie na substituci
N300 B964 Uroinfekt - Proteus Mirabilis, ATB dle citlivosti
Malnutrice
E785 Hyperlipidémie
Další anamn. data jsou uvedena v OA.
U5040 Barthel index vstupně: 20/100
U5110 Rozšířený (kognitivní) Barthel index: 90/90

EPIKRÍZA:

Pro hypokalémii probíhala přechodně substituční perorální terapie. Pro přetrvávající serózní sekreci z rány nasazena empirická ATB profylaxe, sekrece z rány postupně ustupuje, okolí klidné, probíhají pravidelné kontroly ortopedem.

Nekomplikovaně přeléčen uroinfekt. Pacientka doma chodila s 1 vycházkovou holí, u nás vertikalizována v pultovém chodítku, vertikalizace do sedu samostatně, do stoje s lehkou dopomocí, v pultovém chodítku zvládne ujít cca 40m po chodbě s důsledným a důrazným odlehčením LDK. Při rehabilitaci postupně dochází ke zvýšení celk. kondice, zlepšení lokálního nálezu, i hybnosti a svalové síly operované LDK. Pacientka při rehabilitaci dobře spolupracující, pro dekondici předpoklad protahovanějšího průběhu rehabilitace, nyní hledáme následná lůžka – v plánu překlad do rehabilitačního centra Chvaly ve čtvrtek 17.9.
Pacientku překládáme na neurologii ÚVN, za převzetí a další péči o pacientku děkujeme.

DOPORUČENÍ:

Režimové restrikce a opatření – uvedeny výše.

Doporučujeme dnes převaz oper. rány s Betadine, doplnit RTG nativní skiagram operované kyčle vleže, zítra konzilium ortopeda k lůžku ke zhodnocení RTG a operační rány s příp. extrakcí stehů; na čtvrtek je plánovaný a dopluvený překlad do rehab. centra Chvaly, doporučujeme sanitou vleže za účelem minimalizace rizik vykloubení kyčelní endoprotézy.

DOPORUČENÁ MEDIKACE:

FLONIDAN 10MG 0.5-0-0 TBL od 17.9. přestat podávat

EGILOK 25MG 1-0-1 TBL

VERZENIOS 100MG TBL nyní ne (užívá jinak 1-0-1)

ANASTROZOL TEVA 1MG 1-0-0 TBL

SORVASTA 20MG 0-0-1 TBL

VIDEMEL 600MG/400IU 0-0-1 TBL

LACTULOSE AL 667MG/ML SIR 1-1-1 při obstip. DAV

NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN 1-0-1 LAH

PROTIFAR POR PLV 2-2-2 DAV

PROBIO-FIX 1-1-1 CPS

BURONIL 25MG 0-0-0-1 TBL při nespavosti

AFEXIL 500MG 2-2-2-2 TBL

VAS 4+ , min.odstup: 6 hod. , max.: 8.00 TBL denně

při VAS 2-3 podávat 1-1-1-1

lék 1. volby

ZALDIAR 37,5MG/325MG 2-2-2-2 TBL

VAS 4+ , min.odstup: 6 hod. , max.: 8.00 TBL denně

při VAS 2-3 podávat 1-1-1-1

lék 2. volby

LOPERON 2MG 1tbl. při průjmu CPS užívá max. 8 tbl. /den takto z dopor. onkologa

INHIXA 4000IU(40MG)/0,4ML INJ SOL ISP 0-0-1 INJ do podkoží v prevenci tromboembolie

AMOKSIKLAV 1 G 875MG/125MG 1-1-1 TBL

od 7.9. 6-14-22 hod.

z ortop. indikace empir. při sekreci z rány

Ve 14 hodin poslední dávka

V Praze, dne: 15.09.2026

MUDr. Miroslav Kukan
vedoucí lékaře lůžkové části

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny

MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA
primář Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
ÚVN Praha

ošetřující lékař

Propouštěcí zprávu převzala dne: 15.09.2026

Mgr. SVOBODOVÁ EVA

